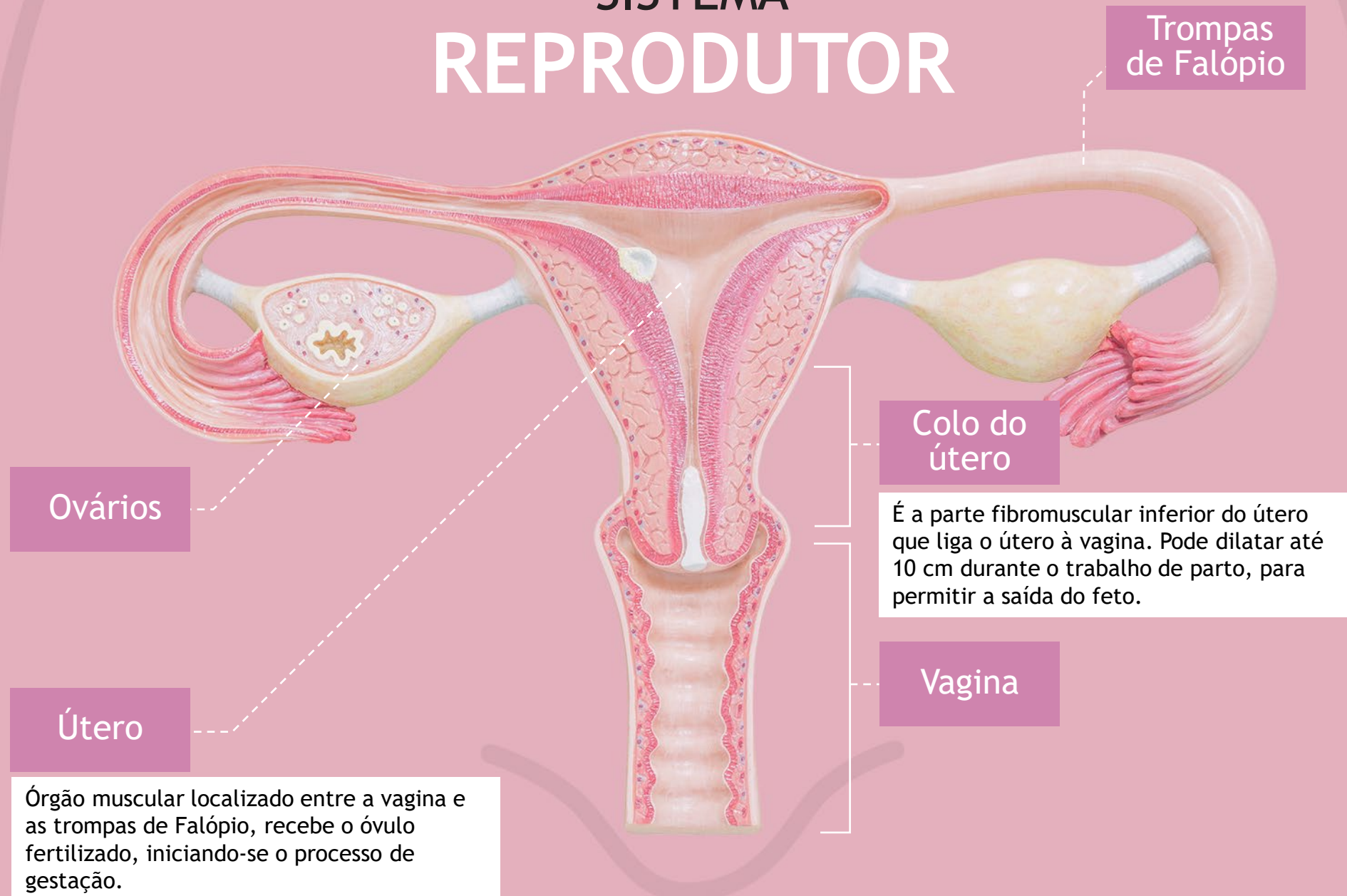


Lançamento
MISOFAR



Angola
Abril de 2024

SISTEMA REPRODUTOR

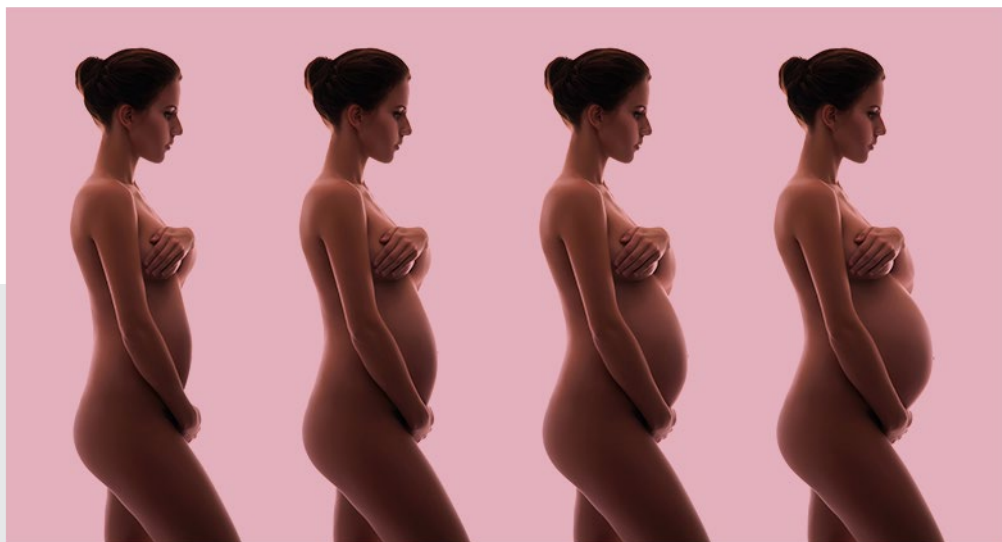




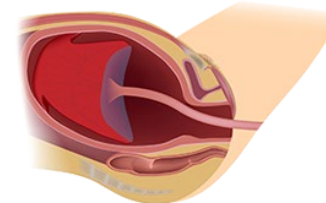
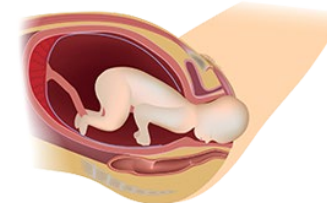
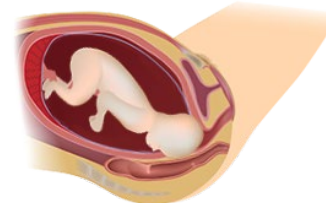
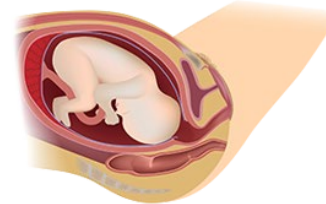
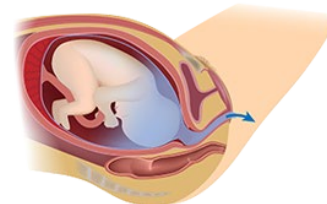
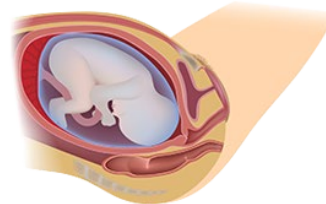
misofar₂₅
MISOPROSTOL μ g

GESTAÇÃO E PARTO

A duração normal da gestação situa-se entre **38 e 42 semanas.**



Dilatação



Parto

Dequitação ou expulsão da placenta

O **parto ou nascimento** é o culminar da gravidez humana, quando o feto sai do útero materno.

Considera-se que as mulheres entram em trabalho de parto com o **aparecimento de contracções uterinas regulares**, as quais vão aumentando de intensidade e frequência enquanto o colo do útero sofre alterações fisiológicas.

DILATAÇÃO

FASE LATENTE

Inclui o tempo e as contracções necessárias para alcançar 4 cm de dilatação, altura em que se considera que o trabalho de parto está em curso.

FASE ACTIVA

Começa com a dilatação a 4 cm e culmina nos 10 cm de dilatação.



Apagamento: torna o colo do útero mais fino. Diminuição em altura do canal endocervical.

Maturação do colo do útero: alteração na consistência do colo do útero, que se torna mais mole.

Caracteriza-se pela sua progressiva dilatação do colo do útero.

A dilatação é medida de 0 a 10 cm e **considera-se que o trabalho de parto começa quando esta está em 3-4 cm.**

TRABALHO DE PARTO: PORQUÊ INDUÇÃO?

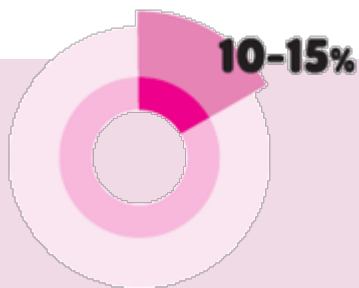
O principal objectivo da indução do parto é
PREVENIR UMA CESARIANA.

Eventos adversos
perinatais

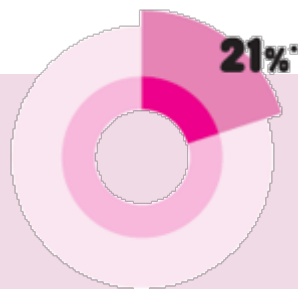
Maior tempo de
recuperação

Complicações
pós-operatório

Riscos maternos
e fetais evitáveis



A Taxa de Cesariana óptima deverá rondar os 10-15%, sendo que países com taxas <20% reportam taxas de mortalidade maternas e perinatais inferiores.



Porém, a Taxa de Cesariana global observada é de 21%, ou seja, um valor acima do desejado.

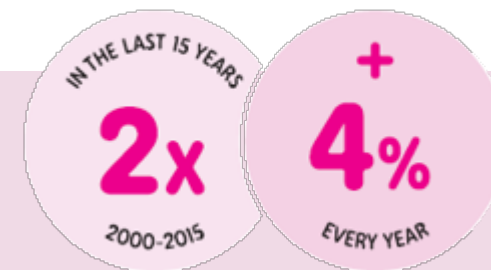
CS Increased risk of:^{5,8}



- Maternal Thromboembolism
- Hemorrhage
- Infection
- Abnormal Placentation in Subsequent Pregnancies



- Newborn Respiratory Morbidity
- Obesity
- Diabetes
- Atopy in Childhood



Além disso, nos últimos 15 anos esse valor tem duplicado, estimando-se um aumento de 4% na taxa de cesarianas a cada ano.

TRABALHO DE PARTO:

MÉTODOS DE INDUÇÃO

EM CASO DE
COLO DO
ÚTERO
FAVORÁVEL



Quando o colo do útero está favorável ou maturado, são usados medicamentos oxitócicos para **induzir o trabalho de parto** mediante a estimulação das **contrações uterinas**.

Oxitocina

A oxitocina, uma hormona que tem um efeito estimulante sobre os músculos lisos do útero, especialmente no fim da gestação, durante o trabalho de parto e no período pós-parto.

Metilergometrina

Usada especificamente para aumentar a frequência e amplitude das contrações uterinas.



QUANDO O COLO
DO ÚTERO
PRECISA DE
SER MATURADO

Quando o colo do útero não está maturado ou favorável, são utilizados medicamentos que estimulam a maturação cervical inicial para **induzir o trabalho de parto** (prostaglandinas).

DINOPROSTONA

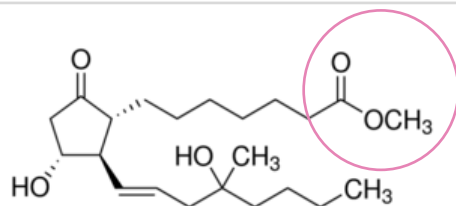
MISOPROSTOL

misofar²⁵
MISOPROSTOL 125

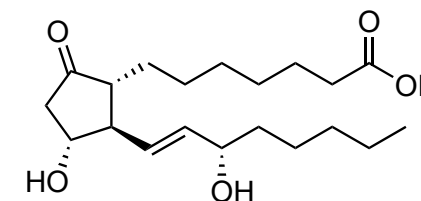
O QUE É MISOFAR 25?

O **misoprostol**, a substância activa do Misofar 25®, é um **análogo sintético da prostaglandina E1**: consiste num éster metílico no átomo de carbono na posição 16 da prostaglandina E-1.

MISOPROSTOL



PROSTAGLANDINA E1



APRESENTAÇÃO



FORMA FARMACÊUTICA

Comprimido vaginal redondo, de cor branca, com uma ranhura num dos lados e 9 mm de diâmetro.

PRODUTO HOSPITALAR



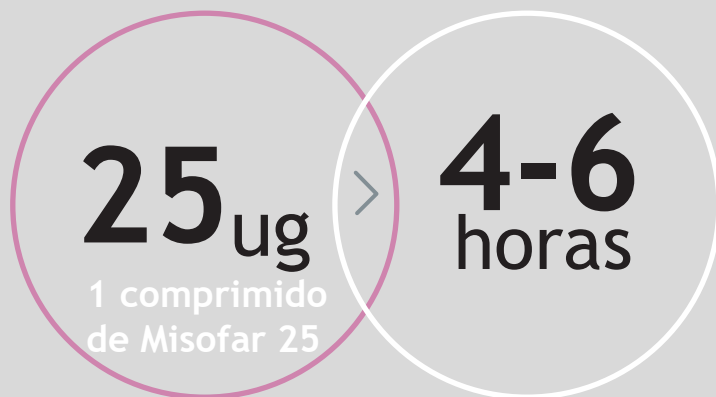
APRESENTAÇÃO

Embalagem de 8 comprimidos em blisters de alumínio.

Não requer condições especiais de conservação.

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: Maturação cervical e indução do parto de termo, sobretudo em casos de colo do útero imaturo, sempre que não existam contraindicações fetais ou maternas

POSOLOGIA



- A dose de 25 µg pode ser repetida a cada 4-6 horas até um máximo de 4-6 administrações.
- A dose deve ser adaptada à resposta da paciente (deverá ser sempre mantida nas menores concentrações que garantam uma resposta uterina satisfatória).
- A segurança e eficácia de Misofar 25 em mulheres grávidas com menos de 18 anos não foram estabelecidas.

Misofar 25 é administrado por via vaginal:



> Retire o comprimido vaginal do blister.



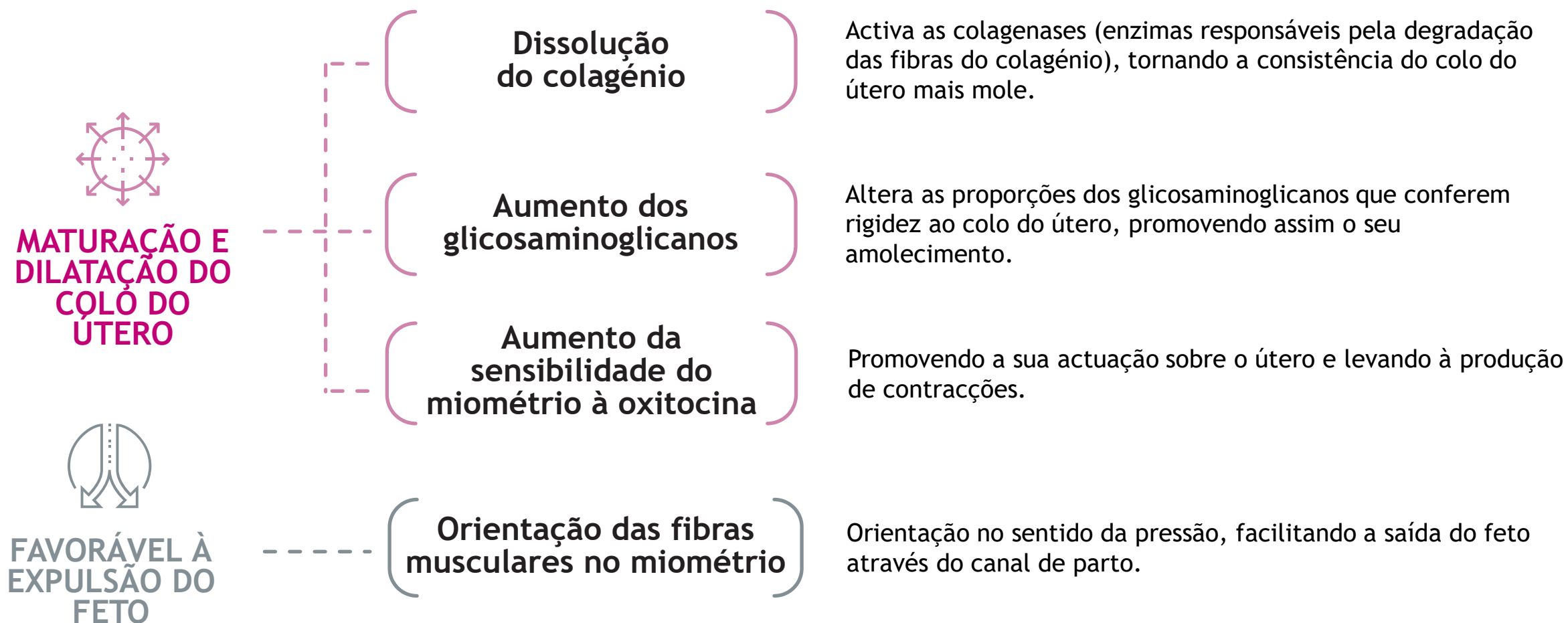
> A paciente deve estar **deitada** com os **joelhos dobrados e junto ao peito**.



> Usando a **ponta do dedo médio**, deve **inserir-se o comprimido dentro da vagina**, o mais **profundamente possível** sem causar desconforto.

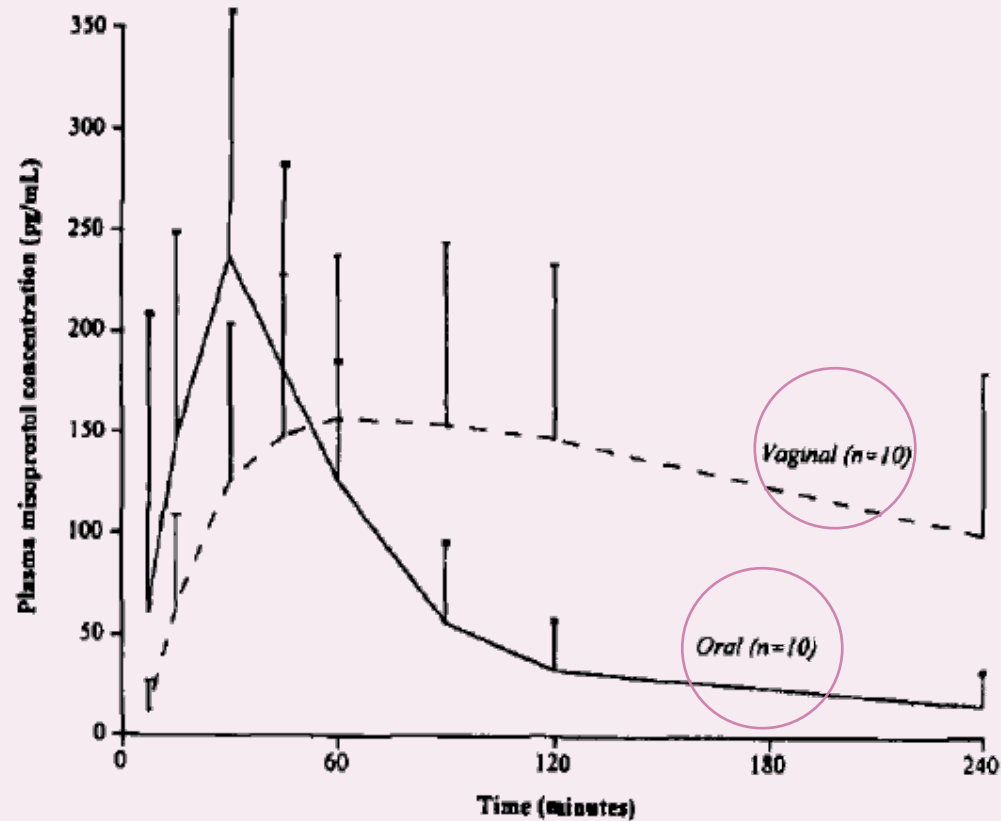
MISOFAR 25

MECANISMO ACÇÃO



FARMACOCINÉTICA

ADMINISTRAÇÃO ORAL vs. VAGINAL



**BIODISPONIBILIDADE
VAGINAL**

3 VEZES MAIOR

Plasma Concentration

INCREASE

PEAK

DECLINE

REMAIN

Vaginal

GRADUALLY

1-2H

SLOWLY (4H)

STABLE (FOR 6H)

Oral

RAPIDLY

< 1H

RAPIDLY (2H)

LOW

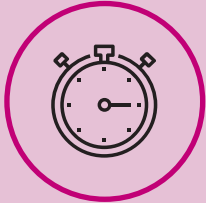
FARMACOCINÉTICA

ADMINISTRAÇÃO ORAL vs. VAGINAL

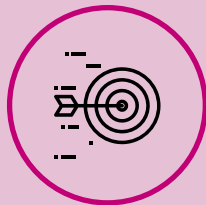
ORAL



Os níveis mais elevados do ácido misoprostol são alcançados no espaço de **12,5 a 60 minutos**.



Os níveis **baixam drasticamente** até ao minuto 120 e permanecem baixos após este ponto.



O **efeito foi mais rápido** e o aumento inicial foi mais acentuado do que na administração vaginal.

VAGINAL



Aumento gradual das concentrações do ácido misoprostol, alcançando-se os níveis mais elevados entre os 60 e 120 minutos, os quais se reduzem gradualmente para 61% dos níveis mais elevados ao minuto 240 após a administração.



Os níveis plasmáticos **permanecem relativamente estáveis** durante 6 horas após a administração.



O **aumento do tônus foi mais duradouro**. As contracções uterinas aumentaram lenta e gradualmente - estímulo duradouro da contractilidade.



Evita o efeito de primeira passagem pelo fígado, evitando-se desta forma que parte do Misoprostol seja imediatamente metabolizado.

MISOPROSTOL

Duplo mecanismo de acção: actua no útero e no colo do útero (amadurecimento, dilatação, amolecimento).

Imita o **processo natural** do parto.

Eficaz em **colo do útero imaturo**.

Maior probabilidade de **parto vaginal** (81% às 24h).

OXITOCINA

Mecanismo de acção simples: actua apenas no útero.

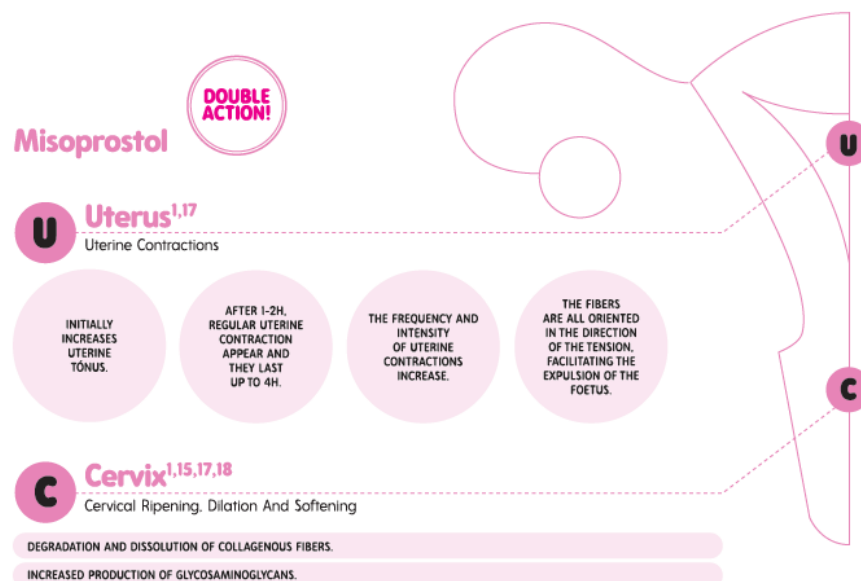
Só é eficaz em casos de **colo do útero maduro**.

Taxa de cesariana superior (36% vs 19%).

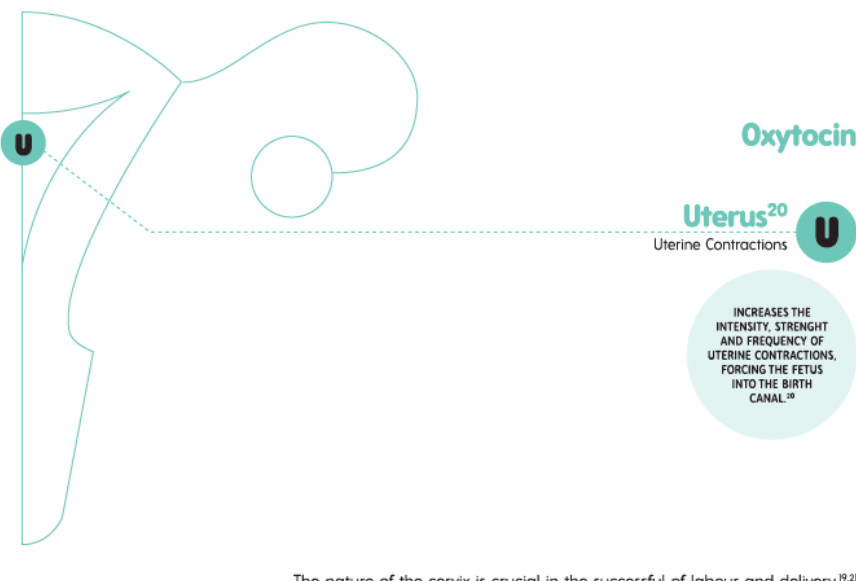
CONCORRENTES DE

MISOFAR 25

MISOPROSTOL VS OXYTOCIN



MISOPROSTOL VS OXYTOCIN



The nature of the cervix is crucial in the successful of labour and delivery.^{19,21}

Misoprostol starts uterine activity while induces cervical ripening, mimicking the natural labour process.¹⁹

Oxytocin starts uterine activity and is only effective when the cervix is favourable.⁶

MISOPROSTOL

Duplo mecanismo de acção: actua no útero e no colo do útero (amadurecimento, dilatação, amolecimento).

Imita o **processo natural** do parto.

Eficaz em **colo do útero imaturo**.

Maior probabilidade de **parto vaginal** (81% às 24h).

OXITOCINA

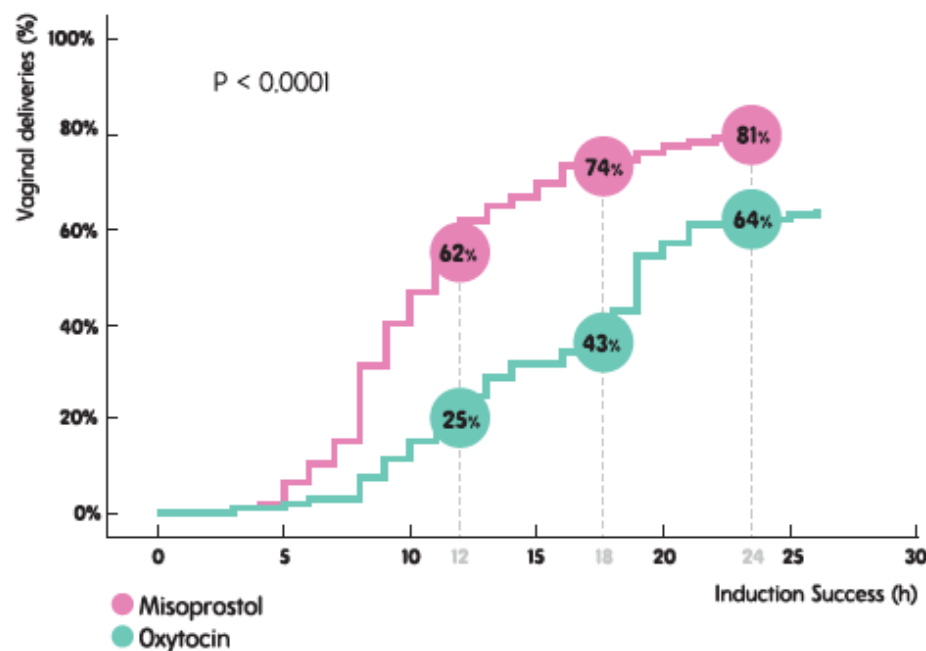
Mecanismo de acção simples: actua apenas no útero.

Só é eficaz em casos de **colo do útero maduro**.

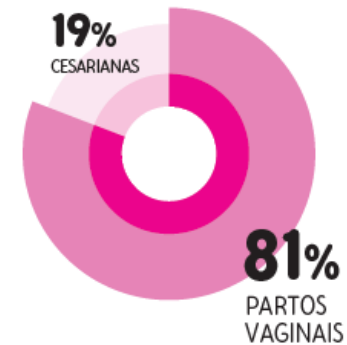
Taxa de cesariana superior (36% vs 19%).

CONCORRENTES DE

MISOFAR 25

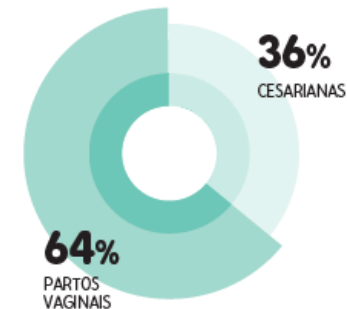


Misoprostol



$n=105$ (mulheres com colo do útero imaturo) $p=0.008$
Adaptado de 2.

OXITOCINA



Misofar 25µg[®] resulta num início mais rápido do parto e numa taxa superior de partos vaginais que a oxitocina.²

MISOPROSTOL

Análogo da **PGE1**.

Comprimidos vaginais.

Mais eficaz: maior probabilidade de **parto vaginal** (às 12 e 24h).

Menor tempo entre indução e parto.

Sem condições de conservação especiais.

DINOPROSTONA

Análogo da **PGE2**.

Sistema de libertação vaginal.

Requer **refrigeração** contínua.

CONCORRENTES DE

MISOFAR 25

		Misoprostol PGE ₁	Dinoprostona PGE ₂
PARTO VAGINAL (%)	12h	34.09	19.04
	24h	90.90	47.61
DOENTES QUE NECESSITAM DE OXITOCINA APÓS A INDUÇÃO (%)		29.54	52.38
REQUER REFRIGERAÇÃO CONTÍNUA		NÃO	SIM
PREÇO		BAIXO	ALTO

Adaptado das referências 2, 3, 5-9.

Misofar 25µg[®] é mais eficaz e mais económico que a dinoprostona, apresentando um perfil de segurança semelhante.⁸

MISOFAR 25

PRINCIPAIS VANTAGENS



É o método mais eficaz de indução do trabalho de parto em mulheres com colo do útero imaturo^{5,6}



Bom perfil de segurança^{2,5,8}



Permite Mobilidade

Não existem indicações expressas de que a doente deva permanecer em repouso após a introdução do comprimido vaginal¹



Recomendado pela OMS, FIGO and ACOG¹⁰⁻¹²



Poucos efeitos secundários e menor utilização de analgesia epidural em comparação com outras prostaglandinas e oxitocina^{3,12}



Não requer condições de armazenamento especiais
Estável à temperatura ambiente^{1,2,5,7,8}



Taxa de cesarianas mais baixa
Taxa de partos vaginais mais elevada VS oxitocina e dinoprostona^{2,5,8,12}



Comprimido vaginal: prático, flexível e estável⁵



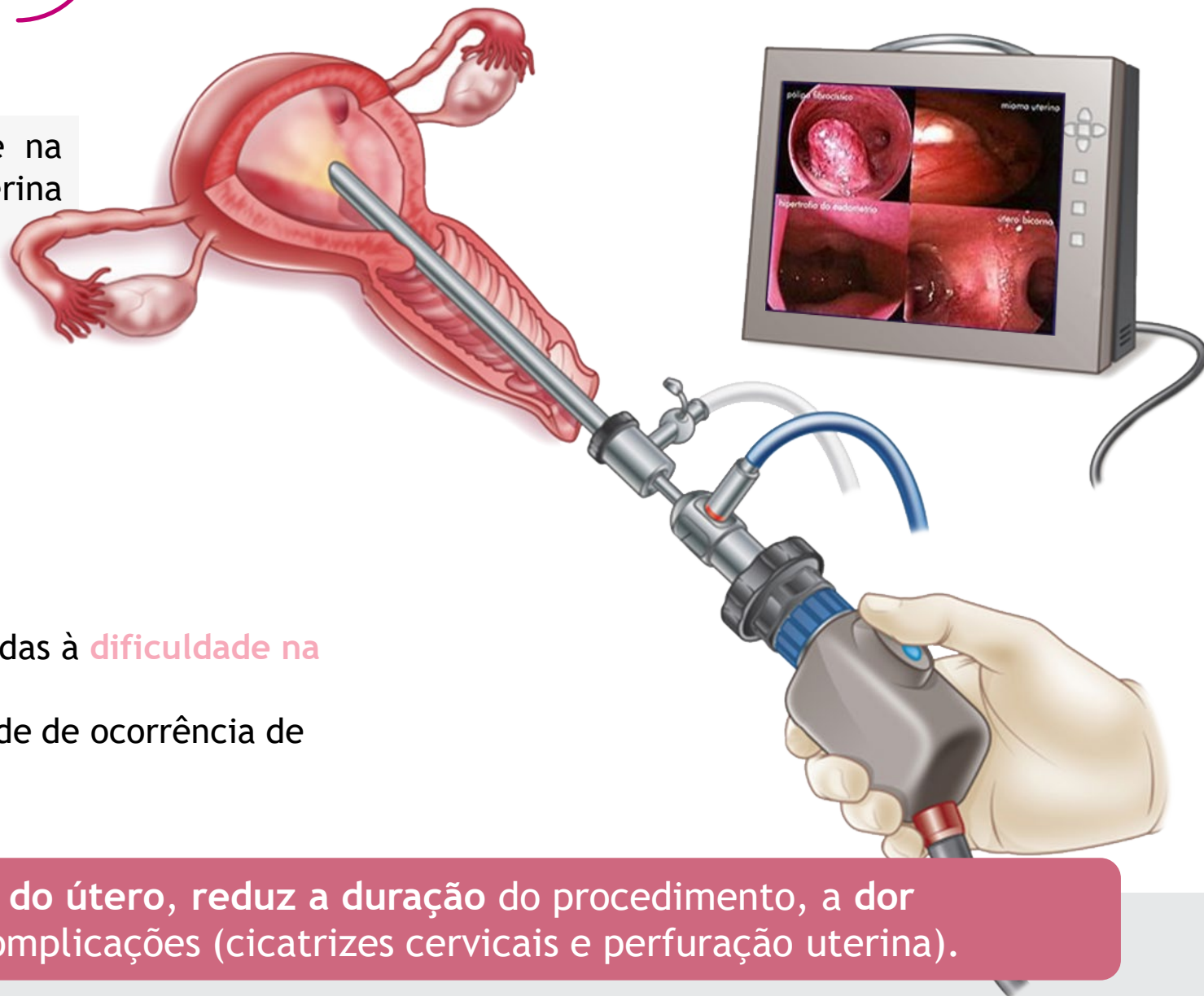
Económico^{2,5,8,9}



misofar₂₀₀

HISTEROSCOPIA

É um procedimento ginecológico que consiste na visualização do colo do útero e da cavidade uterina para fins de **diagnóstico e/ou cirúrgicos**.



Complicações associadas à histeroscopia:

- Cicatrizes cervicais;
- Sangramento;
- Criação de “canais” falsos;
- Perfuração uterina.

Estas complicações são maioritariamente associadas à **dificuldade na dilatação do colo uterino**.

Se o colo for dilatado de antemão, a probabilidade de ocorrência de complicações pode ser reduzida.

O misoprostol facilita a dilatação do colo do útero, reduz a duração do procedimento, a dor resultante do mesmo e a frequência de complicações (cicatrizes cervicais e perfuração uterina).

HISTEROSCOPIA

DE DIAGNÓSTICO

- Metrorragia
- Infertilidade
- Estudos de amenorreia
- Monitorização de doença trofoblástica
- Biopsia de endométrio problemático
- DIU deslocado / corpos estranhos
- Malformações uterinas

CIRÚRGICA

- Mioma submucoso
- Pólipo uterino
- Biopsia dirigida do endométrio
- Tratamento de útero septado ou adesões
- Ablação do endométrio
- Laqueação ou recanalização tubária
- Remoção de DIU
- Tratamento de malformações vasculares da parede uterina
- Histerossalpingografia

APRESENTAÇÃO



FORMA FARMACÊUTICA

Comprimidos vaginais: cápsulas oblongas, de cor branca, com uma ranhura e medindo 14 x 6 mm.

PRODUTO HOSPITALAR



APRESENTAÇÃO

Embalagem de 4 comprimidos em blisters de alumínio.

Não requer condições especiais de conservação.

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: Dilatação do colo do útero não grávido antes de uma histeroscopia ou outro procedimento ginecológico que implique aceder à cavidade uterina.

POSOLOGIA

MODO DE ADMINISTRAÇÃO

DOSE RECOMENDADA

400 µg
Misoprostol

2 comprimidos de Misofar 200

2-8
Horas
antes

Em mulheres **sem**
história de
cesariana
anterior ou
cicatrices
uterinas

2-4
Horas
antes

Em mulheres **com** história de
cesariana
anterior ou
cicatrices
uterinas



Retire o comprimido vaginal do blister.



A paciente deve estar deitada de costas com os joelhos dobrados e junto ao peito.



O comprimido vaginal deve ser inserido usando a ponta do dedo médio.

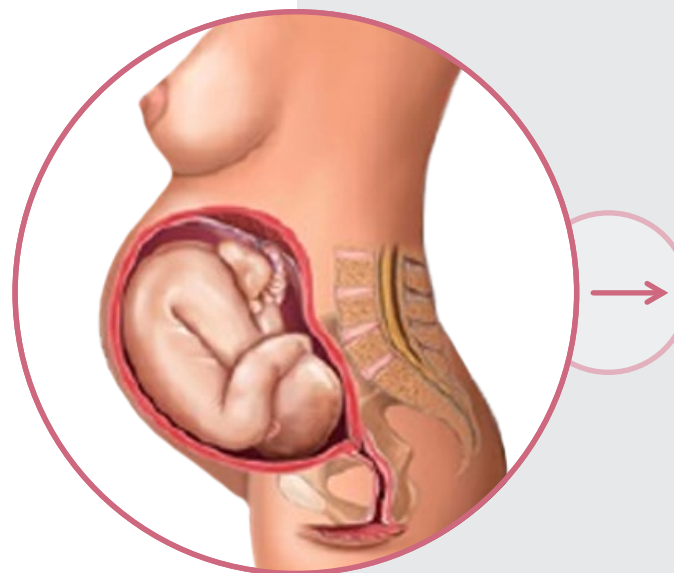
MISOFAR 200

MODO DE ACTUAÇÃO

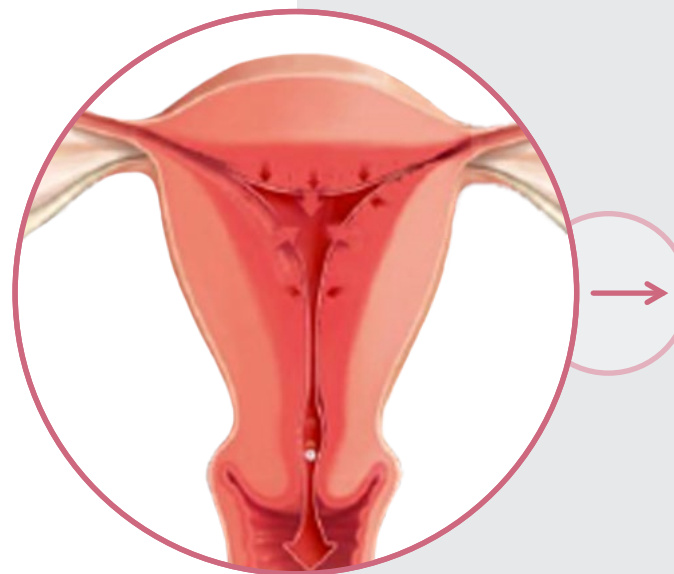
O mecanismo de acção é o mesmo do Misofar 25, mas a dosagem é diferente (200 mcg).

O útero de uma mulher no fim da gestação é muito diferente de um útero que não contém um feto (útero não grávido), como no caso de mulheres que vão ser sujeitas a **histeroscopia**.

PORQUÊ?



No útero de uma grávida, os receptores de oxitocina encontram-se naturalmente activos e em maior número, sendo necessária uma dose menor de misoprostol para a dilatação do colo do útero.

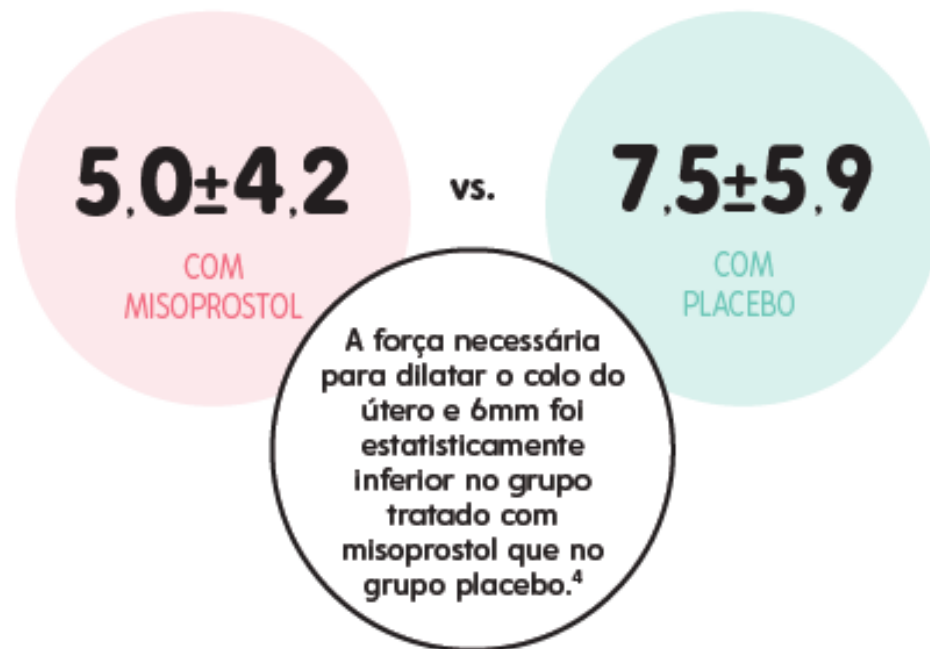


No útero não grávido, os receptores de oxitocina encontram-se em menor número, o que faz com que seja necessária uma dose superior de misoprostol para a maturação e dilatação do colo do útero .

MISOFAR 200

FORÇA PARA DILATAR COLO ÚTERO

Força necessária para dilatar o colo do útero em 6mm⁴
(n, média±DP)

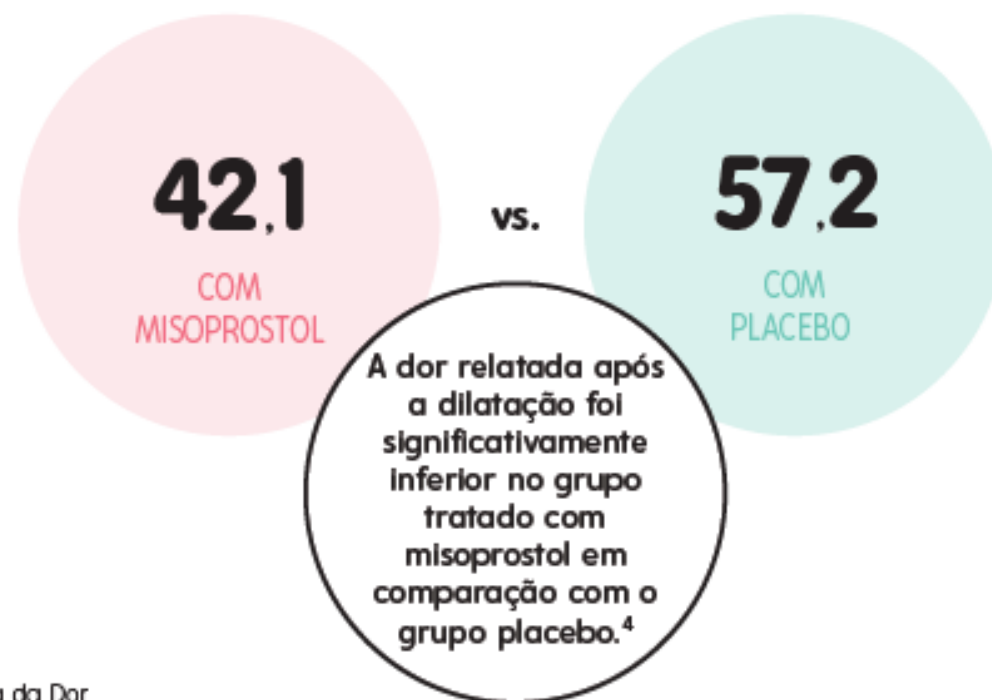


P<0,02 | Misoprostol n=41 | Placebo n=50

Misofar 200µg[®] reduz a força necessária para dilatar o colo do útero durante uma histeroscopia.⁴

MISOFAR 200 DOR

Escala da Dor EVA^{#4}



*EVA – Escala Visual Análoga da Dor

P<0,004 | Misoprostol n=50 | Placebo n=51

Misofar 200µg[®] reduz a dor experienciada durante uma histeroscopia.⁴

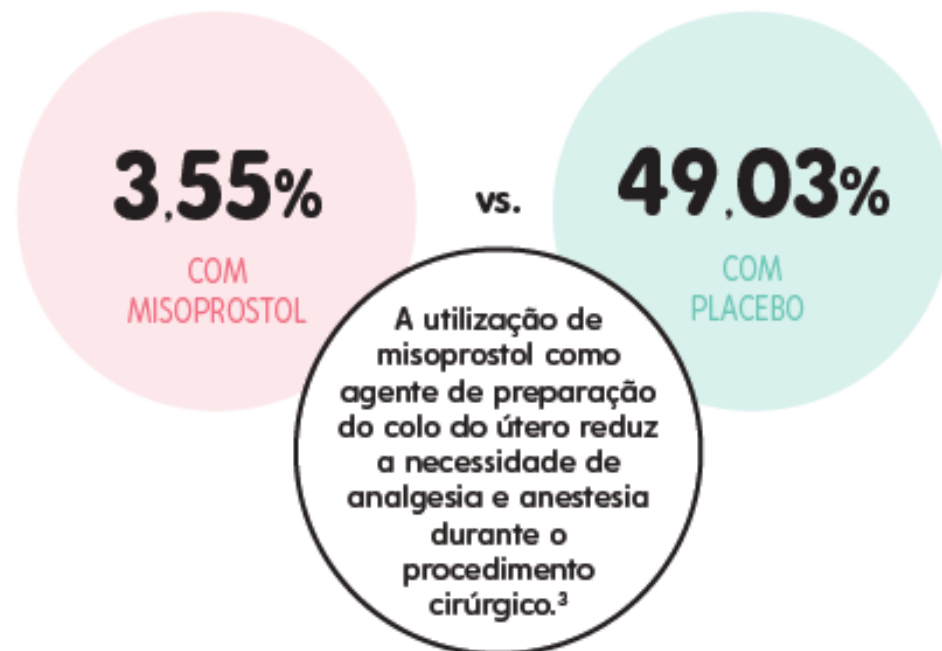
Factores relacionados com dor severa ou intolerável:

- Nuliparidade.
- Patologia cervical.
- Duração do procedimento (>2 min).

MISOFAR 200

ANALGESIA E ANESTESIA

Taxa de doentes que necessitaram de analgesia ou anestesia para concluir o procedimento³



P<0,0001 | Misoprostol n=141 | Placebo n=206

Misofar 200µg[®] facilita a histeroscopia e reduz a necessidade de analgesia ou anestesia.⁴

MISOFAR 200

PRINCIPAIS VANTAGENS



Eficaz
e fácil de utilizar^{3,4}



Reduz o risco de complicações:
minimiza as lesões
cervicais e uterinas^{2,3,4}



Não requer condições
de armazenamento
especiais^{1,3}



Reduz a força
necessária para
a dilatação⁴



Facilita a histeroscopia e
torna-a mais confortável
para as pacientes⁴



Económico²⁻⁴



Reduz a dor
durante a histeroscopia⁴



Reduz a necessidade
de analgesia e anestesia^{3,4}



Reduz a resistência
do colo do útero^{2,3}

Questões?

